

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

1. Ορισμός και φιλοσοφία της διακομιδής.

Η διακομιδή ενός ασθενούς αποτελεί μια διακριτή ιατρική πράξη η οποία εντάσσεται στο φάσμα της επείγουσας φροντίδας και έχει ιδιαίτερο ρόλο και ειδικό βάρος στην ΠΦΥ. Δεν περιλαμβάνει την απλή μεταφορά, αλλά είναι μια οργανωμένη, απαιτητική διαδικασία κατά την οποία ο ασθενής ή τραυματίας αξιολογείται, σταθεροποιείται και παραδίδεται σε ανώτερο επίπεδο φροντίδας με τρόπο που περιορίζει τον κίνδυνο επιδείνωσης. Η διακομιδή – όσο κι αν μοιάζει απλή διαδικασία ρουτίνας – απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες, κλινική κρίση, οξυδέρκεια και ικανότητα τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων προ και κατά τη διάρκειά της.

Στόχος κάθε διακομιδής είναι η ασφαλής, γρήγορη, χρονικά κατάλληλη και ιατρικώς αιτιολογημένη μεταφορά του ασθενούς σε υγειονομική μονάδα (*συνήθως σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσοκομείο*) που διαθέτει τις απαραίτητες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο σημείο της πρώτης εκτίμησης. Η διαδικασία περιλαμβάνει εκτίμηση της αναγκαιότητας, κατάλληλη προετοιμασία των εμπλεκομένων, συνεχή παρακολούθηση, παρεμβάσεις κατά ανάγκη και τεκμηριωμένη παράδοση.

Ο ιατρός της ΠΦΥ αποτελεί το πρώτο επιχειρησιακό επίπεδο της αλυσίδας επιβίωσης. Είναι κύριος υπεύθυνος (*με τη βοήθεια της ομάδας του ΤΕΠ της ΠΦΥ ή των διασωστών*) για την αρχική αναγνώριση του επείγοντος, τη σταθεροποίηση των ζωτικών λειτουργιών και την οριστική απόφαση για διακομιδή. Η συνεισφορά του καθορίζει καίρια την ποιότητα και την ασφάλεια της συνολικής διαδικασίας, καθώς η έγκαιρη και σωστή προνοσοκομειακή διαχείριση βελτιώνει μετρήσιμα την έκβαση σε όλα τα μείζονα συμβάντα.

Η συνοδεία ιατρού κατά τη διακομιδή αποτελεί βασική ηθική, δεοντολογική και νομική υποχρέωση, είτε ο ασθενής είναι σταθερός, είτε εμφανίζει δυνητική ή πραγματική αστάθεια. Ο ασθενής δεν μεταφέρεται ως «φορτίο», αλλά ως άτομο υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Η απουσία ιατρού από τη διακομιδή ασθενούς που χρήζει monitoring ή με πιθανότητα αποσταθεροποίησης συνιστά παράλειψη ιατρικού καθήκοντος, εκθέτει τον ασθενή σε αδικαιολόγητο κίνδυνο και αντιβαίνει στις βασικές αρχές της ιατρικής ευθύνης. Η θέση αυτή τεκμηριώνεται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005). Έτσι, τονίζεται ότι καμία διακομιδή ασθενούς με διαταραχή ζωτικών λειτουργιών, βάσιμη πιθανότητα επιδείνωσης ή ανάγκη ενεργών παρεμβάσεων (*π.χ. αεραγωγός, αναπνοή, κυκλοφορία, αναλγησία, αντιμετώπιση των επιπλοκών, κ.λπ.*) δεν επιτρέπεται να εκτελείται άνευ συνοδείας ιατρού - κυριολεκτικά «στον αυτόματο» - ή μόνο με το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Στην ΠΦΥ, ειδικά στη χώρα μας, όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι, το τοπίο δυσπρόσιτο – ορεινό ή νησιωτικό – και οι αποστάσεις ενίοτε τεράστιες, η συνοδεία ιατρού δεν αποτελεί απλώς επιλογή, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της ασφαλούς διαχείρισης ενός ασθενούς σε προνοσοκομειακό επίπεδο. Η παρουσία ιατρού κατά τη διακομιδή – στο πλευρό του ασθενούς – θεωρείται ως η ελάχιστη και στοιχειώδης προϋπόθεση για την ασφαλή μεταφορά και για τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας.

2. Κριτήρια απόφασης για διακομιδή.

Η απόφαση για τη διακομιδή ενός ασθενούς ή τραυματία βασίζεται σε αντικειμενικά κλινικά δεδομένα και στην εκτίμηση των διαθέσιμων πόρων της μονάδας ΠΦΥ. Αποτελεί κρίσιμη ιατρική πράξη, καθώς καθυστέρηση, αναβολή ή οποιαδήποτε λανθασμένη επιλογή επηρεάζουν άμεσα – και πολλές φορές μη αναστρέψιμα – τη συνολική πρόγνωση.

Τα βασικότερα κριτήρια για τη λήψη απόφασης διακομιδής, είναι:

- i. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση με τους διαθέσιμους πόρους:** Οποιαδήποτε κλινική κατάσταση υπερβαίνει τις δυνατότητες διάγνωσης, διαχείρισης ή θεραπείας της ΠΦΥ θεωρείται ως απόλυτη ένδειξη διακομιδής. Η έλλειψη συγκεκριμένων παρεμβάσεων (*εργαστηριακών εξετάσεων, βασικών ή πιο προηγμένων απεικονιστικών μεθόδων*) και εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού καθιστά τη διακομιδή αναγκαία και επιβεβλημένη.

- ii. **Αποσταθεροποίηση ζωτικών παραμέτρων:** Τιμές υψηλού κινδύνου στα συστήματα NEWS2, qSOFA και Shock Index υποδεικνύουν επικείμενη ή εξελισσόμενη οργανική δυσλειτουργία. Κάθε ασθενής με μεταβολή ζωτικών σημείων εντός επικίνδυνων ορίων πρέπει να μεταφέρεται σε ανώτερο επίπεδο φροντίδας, ανεξαρτήτως αρχικής διάγνωσης.
- iii. **Υποπτο ή επιβεβαιωμένο μείζον τραύμα ή πολυτραύμα / οξύ καρδιαγγειακό συμβάν / ΑΕΕ / οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια:** Καταστάσεις με υψηλή θνητότητα και σαφή εξάρτηση από το δίπτυχο «*χρόνος - κρίσιμος χειρισμός*» απαιτούν άμεση διακομιδή, μετά την αρχική σταθεροποίηση. Τοπικά, περιφερειακά ή μη εξειδικευμένα κέντρα δεν πρέπει να επιχειρούν οριστική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.
- iv. **Ανάγκη απεικόνισης ή παρεμβάσεων που δεν υποστηρίζονται στην ΠΦΥ:** Η κλινική αναγκαιότητα διενέργειας απεικόνισης με CT ή MRI, εξειδικευμένων υπερήχων, ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων ή επεμβατικών πράξεων, αποτελεί σαφή ένδειξη μεταφοράς, ειδικά όταν η κλινική απόφαση και η περαιτέρω αντιμετώπιση εξαρτάται από αυτά.
- v. **Αρχή “time-sensitive emergencies → time-sensitive transport”:** Σε καταστάσεις όπου η καθυστέρηση επιδεινώνει την έκβαση (*STEMI, ΑΕΕ, πολυτραύμα, σήψη*), η διακομιδή πρέπει να ενεργοποιείται άμεσα. Ο χρόνος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα πρόγνωσης και δεν πρέπει να δαπανάται σε παρεμβάσεις που δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα.
- vi. **Διακομιδή λόγω κοινωνικών συνθηκών:** Η διακομιδή συχνά επιβάλλεται όχι μόνο με κλινικά κριτήρια, αλλά κι από το περιβάλλον φροντίδας, όταν αυτό δεν κατοχυρώνει την ασφάλεια του ασθενούς (*ασθενείς χωρίς φροντιστές, άστεγοι, θύματα κακοποίησης κ.λπ.*).

3. Σταθεροποίηση πριν τη Διακομιδή – τα κρίσιμα 10 λεπτά (*The Golden 10 Minutes*)

Η σταθεροποίηση πριν από οποιαδήποτε διακομιδή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προνοσοκομειακής φροντίδας. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιδείνωσης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις επικεντρώνονται στις βασικές λειτουργίες και εφαρμόζονται με δομημένο τρόπο, σε σύντομο χρονικό διάστημα αλλά όχι βιαστικά. Η ομάδα του ΤΕΠ της ΠΦΥ αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας.

- i. **Αεραγωγός (Airway):** Η εξασφάλιση βατού αεραγωγού προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας. Περιλαμβάνει - *όταν αυτή απαιτείται* - την τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού αεραγωγού, την αναρρόφηση των εκκρίσεων και την παροχή οξυγόνου σε κατάλληλη ροή. Σε ασθενείς ληθαργικούς, με μειωμένο επίπεδο συνείδησης ή κώμα ($GCS < 8$) ή σε ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια πρέπει να αξιολογείται η ανάγκη για πιο ειδικές ενέργειες διαχείρισης του αεραγωγού [*π.χ. ενδοτραχειακή διασωλήνωση, τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας (LMA) ή υπεργλωττιδικής συσκευής (i-gel)*].
- ii. **Αναπνοή (Breathing):** Η υποστήριξη της αναπνοής στοχεύει στη διατήρηση επαρκούς οξυγόνωσης και σταθερού αερισμού προ και κατά τη διάρκεια της διακομιδής.
 - **Οξυγόνο:** ρυθμίζεται με βάση τον κορεσμό του O_2 - SpO_2 (92-94% ή 88-92% σε ΧΑΠ). Επιλογή συσκευής ανάλογα με την ανάγκη (μάσκα Venturi, μη επανεισπνοής, κ.λπ.).
 - **NIV/CPAP:** εφαρμόζεται σε παρόξυνση ΧΑΠ, οξύ καρδιογενές πνευμονικό οίδημα ή αναπνευστική κόπωση, με ασθενή σχετικά συνεργάσιμο υπό συνεχή παρακολούθηση (monitoring) κι εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις (*π.χ. μειωμένο επίπεδο συνείδησης, ΚΕΚ ή τραύμα προσώπου, αιμοδυναμική αστάθεια, έμετοι, κ.λπ.*).
 - **Νεφελοποιήσεις:** επί βρογχόσπασμου με σαλβουταμόλη ή/και ιπρατρόπιο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κορτικοστεροειδή επί παροξυσμού άσθματος ή ΧΑΠ. Εκτίμηση των κλινικών παραμέτρων και της κλινικής εικόνας μετά από κάθε νεφελοποίηση.
 - **Πνευμονικό οίδημα:** χορηγείται οξυγόνο σε υψηλή ροή - *ενώ προτιμάται η συσκευή CPAP όπου αυτό είναι εφικτό* - και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή βάσει ενδείξεων.
 - **Αντιμετώπιση αναπνευστικής κόπωσης:** προϊούσα δύσπνοια, ταχύπνοια, χρήση των επικουρικών μυών ή μείωση του επιπέδου συνείδησης, λήθαργος ή ημικωματώδης κατάσταση αποτελούν ενδείξεις ανάγκης για άμεση κλιμάκωση της υποστήριξης.

- iii. **Κυκλοφορία (Circulation):** Εξασφαλίζεται τουλάχιστον μία φλεβική γραμμή επαρκούς διαμέτρου. Χορηγούνται υγρά στους υποογκαιμικούς ασθενείς με προσοχή σε καρδιακή ανεπάρκεια ή πνευμονικό οίδημα. Τα φάρμακα που απαιτούνται για έλεγχο ΑΠ, ρυθμού ή οξέος πόνου χορηγούνται πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση αιμορραγίας, προέχει ο άμεσος έλεγχός της με συνεχή τοπική πίεση, ισχαιμη περίδεση ή ακινητοποίηση.
- iv. **Μεταβολικοί και υποστηρικτικοί παράγοντες:** Ελέγχονται τα επίπεδα γλυκόζης και αντιμετωπίζεται η υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία με βάση τα πρωτόκολλα. Ελέγχεται η θερμοκρασία του ασθενούς προς αποφυγή υποθερμίας ή υπερθερμίας. Αναλγησία πρέπει να χορηγείται χωρίς δεύτερη σκέψη, εφόσον απαιτείται, καθώς το εμμένον οξύ άλγος επιδεινώνει την υπάρχουσα κλινική εικόνα. Βενζοδιαζεπίνες ως αγχολυτικά χορηγούνται μόνον επί σαφών κλινικών ενδείξεων και χωρίς κίνδυνο αναπνευστικής καταστολής.
- v. **Check-list πριν από την αναχώρηση:** Πριν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός διακομιδής, ο ιατρός επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση βασικών σημείων: βατότητα αεραγωγού, επαρκής οξυγόνωση, σταθεροποίηση της κυκλοφορίας, χορήγηση βασικής αγωγής, εξασφάλιση ενδοφλέβιων γραμμών και άλλων υλικών, σύνταξη συνοδευτικών εγγράφων, ενημέρωση του κέντρου υποδοχής και τέλος ασφαλής τοποθέτηση του ασθενούς στο φορείο.

4. Monitoring και συνοδεία κατά τη διαδρομή

Κατά τη διακομιδή ενός ασθενούς ή τραυματία απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών για να διασφαλιστεί η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης.

- **Παρακολούθηση:** Ελέγχονται συστηματικά ο αναπνευστικός ρυθμός (RR), ο κορεσμός του οξυγόνου (SpO₂), η καρδιακή συχνότητα (HR), η αρτηριακή πίεση (BP/MAP), το επίπεδο συνείδησης (GCS/AVPU) και όπου είναι διαθέσιμο, ο καρδιακός ρυθμός - ΗΚΓ. Η καταγραφή γίνεται συνεχής ή περιοδικά ή νωρίτερα εάν υπάρξει κλινική μεταβολή.
- **Οξυγόνο:** Η ροή οξυγόνου προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο με βάση τον κορεσμό και την κλινική συμπτωματολογία. Αυξάνεται σε περιπτώσεις υποξαιμίας και μειώνεται μόνο στους σταθερούς ασθενείς με κίνδυνο υπερκαπνίας. Θεωρείται αυτονόητο ότι προ της διακομιδής έχει ελεγχθεί η στάθμη οξυγόνου στις φιάλες του ασθενοφόρου.
- **Αντιμετώπιση κρίσεων:** Ο συνοδός ιατρός πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για εμφάνιση αρρυθμιών, δύσπνοιας, σπασμών ή σημείων shock, εφαρμόζοντας βασικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα επείγουσας ιατρικής και φροντίδας.
- **Φάρμακα:** Χορηγούνται μόνο όσα είναι απαραίτητα για τη σταθεροποίηση ή διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών και για την αναστροφή αιφνίδιας επιδείνωσης. Αποφεύγονται φάρμακα που ενδέχεται να προκαλέσουν αιμοδυναμική ή αναπνευστική επιβάρυνση.
- **Ασφάλεια:** Ο ασθενής προσδένεται σταθερά στο φορείο. Τοποθετούνται με ορατότητα και ασφάλεια όλες οι γραμμές και οι συσκευές. Ο ιατρός εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε βασικά υλικά και τηρεί τους κανόνες ασφαλούς μετακίνησης εντός του οχήματος.
- **Ευθύνη συνοδού ιατρού:** Ο συνοδός ιατρός (που θεωρείται ο «θεράπων ιατρός» κατά τη διακομιδή) έχει πλήρη ευθύνη για το monitoring, τις παρεμβάσεις και την τεκμηρίωση των συμβάντων μέχρι την παράδοση του ασθενούς σε ανώτερο επίπεδο φροντίδας.

5. Ειδικά Πρωτόκολλα Διακομιδής

α. Μείζον Τραύμα - Πολυτραύμα

- Ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ και του κορμού, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ATLS.
- Έλεγχος κάθε εξωτερικής αιμορραγίας, με άμεση τοπική πίεση ή ισχαιμη περίδεση.
- Εκτίμηση υποογκαιμίας και υποψία shock σε ταχυκαρδία, υπόταση ή ψυχρά άκρα.
- FAST (εάν είναι διαθέσιμο) ή κλινική εκτίμηση για ενδοκοιλιακή αιμορραγία.
- Αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων συνοδών ή απότοκων του τραυματισμού.
- Άμεση διακομιδή (ιδανικά, σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ/ΕΚΕΠΥ και τη δομή υποδοχής) σε κατάλληλο Κέντρο Τραύματος μετά από την αρχική βασική σταθεροποίηση.

β. Καρδιολογικά επείγοντα

- STEMI: ιδανικά επιβάλλεται η άμεση ενεργοποίηση της μεταφοράς του εμφραγματία ασθενούς σε νοσοκομείο με αιμοδυναμικό εργαστήριο, υπό συνεχές monitoring.
- Αρρυθμίες: αναγνώριση των επικίνδυνων ή απειλητικών αρρυθμιών και θεραπευτικές παρεμβάσεις (στην ΠΦΥ και στη διακομιδή) με βάση τα καθιερωμένα πρωτόκολλα.
- Οξύ πνευμονικό οίδημα: οξυγόνο, NIV/CPAP όπου απαιτείται, φαρμακευτική αγωγή.
- Προσοχή σε οποιαδήποτε αιμοδυναμική επιβάρυνση κατά τη διαδρομή.

γ. Αναπνευστικά επείγοντα

- Παρόξυνση ΧΑΠ ή κρίση άσθματος: χορήγηση οξυγόνου με καθορισμένους στόχους με ανάλογη συσκευή, νεφελοποιήσεις με βρογχοδιασταλτικά ή/και κορτικοστεροειδή.
- NIV σε υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις.
- Συνεχής αξιολόγηση πιθανής αναπνευστικής κόπωσης και επάρκειας αερισμού.
- Διακομιδή μόνο με σταθεροποιημένη αναπνοή ή υπό αναπνευστική υποστήριξη.

δ. Νευρολογικά επείγοντα

- Αγγειακό Εγκεφαλικό επεισόδιο (I-AEE/AI-AEE): καταγραφή ώρας εγκατάστασης, αποφυγή μείωσης της ΑΠ ή ελεγχόμενη μείωση της ΑΠ βάσει κλινικών ενδείξεων.
- Αποφυγή αλόγιστης χορήγησης O₂ σε ισχαιμικό ΑΕΕ. Θέση κεφαλής 30-45°.
- Εγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ): διατήρηση οξυγόνωσης, χορήγησης κατάλληλων υγρών, αποφυγή υπότασης και υποκαπνίας. Σταθεροποίηση της κεφαλής και της ΑΜΣΣ.
- Status epilepticus: άμεση χορήγηση αντιεπιληπτικών πριν από τη διακομιδή.

ε. Σήψη και σηπτικό shock

- Έγκαιρη και ενδεδειγμένη (βάσει ενδείξεων) χορήγηση υγρών σε υποογκαιμία.
- Έναρξη κατάλληλων αντιβιοτικών πριν τη διακομιδή, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις.
- Συχνή επανεκτίμηση των ζωτικών σημείων, ανά τακτά διαστήματα (10-15 λεπτά).
- Διακομιδή σε κέντρο με δυνατότητα προηγμένης υποστήριξης (ΜΑΦ/ΜΕΘ).

6. Επικοινωνία με το κέντρο υποδοχής

Η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ και την υγειονομική μονάδα που θα παραλάβει τον ασθενή είναι κρίσιμο μέρος της διαδικασίας και επιτελείται έγκαιρα και δομημένα (βλ. σελ. 375).

- **Καθαρή και σύντομη κλινική αναφορά:** καταγραφή ακριβούς χρόνου και τόπου που ήρθαμε σε πρώτη επαφή με το περιστατικό, περιγραφή περιστατικού, βασικά ευρήματα, ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, SpO₂, T), κύρια κλινική υποψία και επίπεδο σταθερότητας.
- **Τεκμηρίωση παρεμβάσεων:** αναφορά φαρμάκων, υγρών - χρόνος έγχυσης, φλεβικών γραμμών, καθετήρων, διαχείριση αεραγωγών - NIV και κάθε άλλης κλινικής ενέργειας πριν από τη διακομιδή, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια στη φροντίδα.
- **Σαφές αίτημα χώρου ή ειδικότητας:** σαφής ενημέρωση του τριτοβάθμιου ΤΕΠ για την ανάγκη καθορισμένης πορείας (Trauma bay, καρδιολογικό/αιμοδυναμικό τμήμα, κ.λπ.).
- **Προειδοποίηση πιθανής επιδείνωσης:** ενημέρωση για καταστάσεις, πιθανές επιπλοκές ή άλλα στοιχεία που αυξάνουν τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης κατά τη διαδρομή.

7. Παράδοση στον επόμενο ιατρό

Η παράδοση του ασθενούς στο κέντρο υποδοχής πρέπει να γίνεται με δομημένο και κλινικά στοχευμένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η ακρίβεια στη φροντίδα.

- **Δομημένη αναφορά:** ενημερωτικό σημείωμα και παρουσίαση περιστατικού με σειρά ABCDE, περιγραφή τυχόν συμβαμάτων κατά τη διαδρομή, φαρμάκων που χορηγήθηκαν και εξέλιξης των ζωτικών σημείων και της συνολικής κλινικής εικόνας (βλ. σελ. 376).
- **Παράδοση συνοδευτικού υλικού:** ΗΚΓ, εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες (film ή CD) και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη εξέταση παραδίδονται με σαφή τεκμηρίωση.

- **Ωρα έναρξης των συμπτωμάτων:** αναφέρεται με ακρίβεια, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος επηρεάζει την περαιτέρω κλινική αντιμετώπιση (*AEE, STEMI, δηλητηριάσεις*).
- **Επισήμανση των πιθανών κινδύνων:** σύντομη ενημέρωση για πιθανούς παράγοντες αποσταθεροποίησης, τεχνικές δυσκολίες / ελλείψεις κατά την αρχική αντιμετώπιση ή τη διακομιδή και αναγκαίες κρίσιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις που απαιτούν συνέχιση.

8. Νομικά και ηθικά σημεία της διακομιδής

Η διακομιδή αποτελεί ιατρική πράξη με σαφές νομικό και ηθικό πλαίσιο. Ο ιατρός οφείλει να τεκμηριώνει τις αποφάσεις του και να διασφαλίζει τη συνέχεια της φροντίδας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (*N. 3418/2005*). Η ανάγκη της διακομιδής ενός ασθενούς δεν αποφασίζεται «ελαφρά τη καρδιά», απλώς για μετακύλιση της φροντίδας ή/και των όποιων ευθυνών σε κάποιον άλλον, κάπου αλλού, μακριά από εμάς!

- **Καταγραφή της ανάγκης διακομιδής:** Η ένδειξη της διακομιδής τεκμηριώνεται στον ιατρικό φάκελο με βάση την κλινική εικόνα, τα ζωτικά σημεία και τους διαθέσιμους πόρους. Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της ευθύνης του ιατρού (*Άρθρα 2 και 3 του ΚΙΔ*).
- **Άρνηση του ασθενούς:** Σε περίπτωση άρνησης, καταγράφεται η ενημέρωση που δόθηκε σχετικά με τους κινδύνους, η κατανόηση από τον ασθενή και η τελική απόφασή του. Ο ιατρός τεκμηριώνει ότι έδρασε σύμφωνα με την υποχρέωση προστασίας της υγείας του ασθενούς (*Άρθρο 11 του ΚΙΔ*). Σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν κρίνεται ικανός να αποφασίσει (μέθη, ψυχιατρική νόσος, ανήλικος ασθενής) τότε άρνηση της διακομιδής μπορεί να επικαλεστούν – ενυπόγραφα και υπό συνθήκες – οι συγγενείς α' βαθμού.
- **Ευθύνη του συνοδού ιατρού:** Ο συνοδός ιατρός φέρει πλήρως την κλινική ευθύνη κατά τη διάρκεια της διακομιδής: παρακολούθηση, παρεμβάσεις, καταγραφή συμβαμάτων και ασφαλή παράδοση. Η παρουσία του αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της «συνέχειας φροντίδας» (*Άρθρα 2, 9 και 11 του ΚΙΔ*). [*Η μη συνοδεία ασταθούς ασθενούς αποτελεί πιθανή παράλειψη αναγκαίας πράξης, γιατί στερεί τη δυνατότητα άμεσης ιατρικής παρέμβασης σε περίπτωση επιδείνωσης. Κρίνεται δεοντολογικά και νομικά επιλέξιμο να αφηθεί τέτοιος ασθενής χωρίς ιατρική παρουσία*].
- **Έννοια της επαρκούς σταθεροποίησης:** Πριν από τη μεταφορά, ο ασθενής πρέπει να έχει λάβει όλες τις αναγκαίες θεραπευτικές παρεμβάσεις, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος επιδείνωσης κατά τη διαδρομή (*αεραγωγός, αναπνοή, κυκλοφορία, θερμοκρασία, πόνος*). *Η ανεπαρκής σταθεροποίηση θεωρείται σοβαρή παράλειψη ιατρικού καθήκοντος.*

9. Έλεγχος λίστας (Check-list) Διακομιδής

Πριν από την αναχώρηση του ασθενοφόρου, ο ιατρός που οργανώνει τη διακομιδή, αλλά κυρίως ο ιατρός που θα την εκτελέσει πρέπει να επιβεβαιώσει τα ακόλουθα:

1. Εξασφάλιση αεραγωγού και έλεγχος της αναπνοής.
2. Επαρκής οξυγόνωση με κατάλληλη συσκευή και έλεγχος της ροής O₂.
3. Σταθεροποίηση κυκλοφορίας, φλεβική πρόσβαση, υγρά ή φάρμακα, όπου χρειάζεται.
4. Έλεγχος γλυκόζης και αντιμετώπιση υπογλυκαιμίας/υπεργλυκαιμίας.
5. Έλεγχος θερμοκρασίας και πρόληψη υποθερμίας. Επαναθέρμανση επί υποθερμίας.
6. Αναλγησία ή άλλη υποστηρικτική αγωγή, όπου ενδείκνυται.
7. Ασφαλής πρόσδεση ασθενούς και σταθεροποίηση όλων των γραμμών/συσκευών.
8. Παράδοση ενημέρωσης στο πλήρωμα για τις ανάγκες του ασθενούς.
9. Συνοδευτικό έγγραφο διακομιδής: ζωτικά σημεία, διάγνωση, παρεμβάσεις, φάρμακα.
10. Επικοινωνία με το κέντρο υποδοχής και επιβεβαίωση προορισμού.
11. Πρόσβαση σε βασικά υλικά (*οξυγόνο, ambu, φλεβ/θετήρες, φάρμακα πρώτης ανάγκης*).
12. Παρουσία συνοδού ιατρού και ενίοτε ειδικού ιατρού όταν κι εφόσον αυτή απαιτείται.

10. Διαλογή (Triage) και διακομιδή σε μαζικό συμβάν

Σε μαζικό συμβάν ή πολλαπλούς ασθενείς στο ΤΕΠ η προτεραιότητα μετατοπίζεται από την εξατομικευμένη φροντίδα στην εξασφάλιση του μέγιστου αριθμού επιζώντων. Η ορθή διαχείριση στηρίζεται σε τρεις άξονες: **διαλογή, σταθεροποίηση, οργανωμένη διακομιδή.**

- **Triage:** Η διαλογή εφαρμόζεται με βάση τα διεθνώς τυποποιημένα συστήματα διαλογής (*Mass Casualty Triage Systems*), όπως είναι τα συστήματα *START, SALT, mSTART, CareFlight*, κ.λπ. Οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται εύκολα και γρήγορα με γνώμονα την ικανότητα βάδισης, την αναπνοή, την αιμάτωση και το επίπεδο συνείδησης. Η διαλογή είναι **δυναμική διαδικασία** και επανεκτιμάται διαρκώς, καθώς αλλάζουν οι καταστάσεις και οι διαθέσιμοι πόροι. Όταν υπάρχουν ταυτόχρονα πολλοί ασθενείς που χρειάζονται ενδεχομένως διακομιδή, η απόφαση βασίζεται σε κλινικά και λειτουργικά κριτήρια προτεραιοποίησης. Πρώτοι διακομίζονται οι ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν **απειλητική κατάσταση που μπορεί να τροποποιηθεί** (βαριά δύσπνοια, μείζον τραύμα, *shock, STEMI, AEE* εντός θεραπευτικού παραθύρου). Ακολουθούν οι **σταθεροί ασθενείς αλλά υψηλού κινδύνου** οι οποίοι απαιτούν εξειδικευμένη φροντίδα που δεν παρέχεται στη δομή της ΠΦΥ. Τελευταίοι διακομίζονται οι **κλινικά σταθεροί ασθενείς** οι οποίοι μπορούν να παραμείνουν υπό παρακολούθηση χωρίς άμεσο κίνδυνο. Η κατανομή των πόρων (ιατρών, ασθενοφόρων, εξοπλισμού) γίνεται πάντοτε με γνώμονα τη μέγιστη **συνολική ασφάλεια** και τη δυνατότητα του συστήματος να παρέμβει αποτελεσματικά σε κάθε ασθενή. Η προτεραιοποίηση επανεκτιμάται συνεχώς (*δυναμικό triage*), καθώς η κλινική κατάσταση των ασθενών και η διαθεσιμότητα των πόρων μεταβάλλονται.
- **Απόφαση για διακομιδή:** Η προτεραιοποίηση της διακομιδής σε πολλαπλούς ασθενείς βασίζεται όχι μόνο στη βαρύτητα νόσησης, αλλά και στη **σχέση κλινικής ανάγκης - ωφέλειας**, δηλαδή ποιος ασθενής αναμένεται να ωφεληθεί περισσότερο από τη γρήγορη πρόσβαση σε ανώτερο επίπεδο φροντίδας. Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τον χρόνο ευαισθησίας της πάθησης (*time-dependent emergencies*), τη διαθεσιμότητα προσωπικού συνοδείας και την ικανότητα της δομής ΠΦΥ να διατηρήσει ασφαλή παρακολούθηση όσων παραμένουν. Ασθενείς που απαιτούν παρεμβάσεις ή *monitoring* που δεν μπορεί να προσφέρει η ΠΦΥ αποκτούν υψηλότερη προτεραιότητα για διακομιδή.
- **Εξασφάλιση επιπέδου ασφάλειας για όσους περιμένουν:** Οι ασθενείς εκείνοι που δεν διακομίζονται άμεσα, πρέπει να παραμένουν σε ελεγχόμενο χώρο με ορατότητα (για *συνεχές δυναμικό triage*), πρόσβαση σε παροχή οξυγόνου και *monitoring*, όσο αυτά είναι διαθέσιμα. Κάθε πόρος μετά από οποιαδήποτε αλλαγή των δεδομένων (π.χ. *άφιξη άλλων ασθενών ή εξεύρεση ασθενοφόρου*) ανακατανέμεται ανάλογα με τις προτεραιότητες.
- **Επιλογή προορισμού:** Ιδανικά, οι ασθενείς πρέπει να κατευθύνονται στα πλησιέστερα διαθέσιμα νοσοκομεία με δυνατότητες ανάληψης περίθαλψης ανά κατηγορία βλάβης (π.χ. *κέντρο τραύματος, καρδιολογικό κέντρο, χειρουργικό τμήμα*). Έτσι, αποφεύγεται η υπερφόρτωση ενός μόνο νοσοκομείου για όλα τα περιστατικά. Η κατανομή ασθενών ή τραυματιών γίνεται σε συνεργασία με το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ/ΕΚΕΠΥ.
- **Κατανομή ιατρών και προσωπικού:** Ο ιατρός (ιδανικά ειδικός ιατρός) συνοδεύει τον βαρύτερο ασθενή ή εκείνον με πιθανότητα ταχείας αποσταθεροποίησης. Οι λιγότερο κρίσιμες διακομιδές μπορούν να περαιωθούν με εκπαιδευμένο πλήρωμα ασθενοφόρου ή συνοδεία νοσηλεύτη, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του ασθενούς, και μετά από σαφή τεκμηρίωση της απόφασης. Η διακομιδή εκτελείται όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

Συνοπτική αρχή

Σε μαζικά συμβάντα (μαζικές καταστροφές) ή σε περιπτώσεις ασθενών με ανάγκη πολλαπλών ταυτόχρονων διακομιδών, στόχος δεν θεωρείται η ταχύτητα διακίνησης ανά ασθενή, αλλά η αρχική σταθεροποίηση, η σωστή προτεραιοποίηση και η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, σύμφωνα πάντα με την προβλεπόμενη ωφέλεια για τη μέγιστη συνολική επιβίωση.